МЕДИЦИНА КАТАСТРОФ · 3 КУРС · МЕДФАК ЧГУ

ВСМК и лечебно-эвакуационное обеспечение

Что такое Всероссийская служба медицины катастроф, как она устроена по уровням, какие у неё силы, что такое этап медицинской эвакуации и какие виды помощи на нём оказывают — в мирное и в военное время.

17 вопросов занятия | учебник Линченко, КубГМУ, 2015 | ПП № 734 и приказ № 1202н в редакции 2024

Главное за пять минут

1994
создана ВСМК — ПП РФ № 420 от 03.05.1994

№ 734
действующее Положение о ВСМК, ПП РФ от 26.08.2013

5 уровней
федеральный, межрегиональный, региональный, муниципальный, объектовый

4 задачи
реагирование и помощь, эпидочаги, резерв, обучение

2 этапа
классическая схема ЛЭО в мирное время: очаг → больницы вне очага

250 / сутки
ПМГ принимает пострадавших; развёртывает до 150 коек

1992
создан Центроспас — первый отряд профессиональных спасателей

50 за 6 ч
врачебно-сестринская бригада (6 человек) оказывает помощь 50 поражённым

Одна мысль на всё занятие. ВСМК — не отдельное ведомство, а **функциональная подсистема РСЧС**, которая объединяет медицинские силы разных министерств под руководством Министра здравоохранения. Работает она по принципу **этапного лечения с эвакуацией по назначению**: помощь оказывают последовательно и

преемственно, по пути от очага до больницы, где пострадавшему могут помочь исчерпывающе.

Учебник 2015 года местами устарел. Что поменялось — и как отвечать, если спросят по-старому:

- ВЦМК «Защита» больше нет: с 1 марта 2021 года его функции выполняет **Федеральный центр медицины катастроф (ФЦМК) НМХЦ им. Н. И. Пирогова** Минздрава России (ПП РФ № 1671 от 12.10.2020).
- Действующий порядок работы службы — **приказ Минздрава № 1202н от 06.11.2020** (последние изменения — 2024 год). В учебнике его нет.
- Перечень мероприятий первой помощи сейчас утверждён **приказом Минздрава № 220н от 03.05.2024**, а не № 353н (2010), как в учебнике.
- В законе № 323-ФЗ виды помощи названы иначе, чем в учебнике: первичная медико-санитарная, скорая, специализированная. Обе классификации — в вопросе 15.

01 ВСМК: что это такое

ОПРЕДЕЛЕНИЕ · ПП РФ № 734, П. 1

Всероссийская служба медицины катастроф (ВСМК) — функциональная подсистема единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС).

Для развёрнутого ответа добавь, **что ВСМК объединяет** (п. 5 Положения):

1. службу медицины катастроф **Министерства здравоохранения** РФ;
2. службу медицины катастроф **Министерства обороны** РФ;
3. силы и средства **МЧС России, МВД России, Роспотребнадзора**, иных федеральных органов исполнительной власти, органов власти субъектов, органов местного самоуправления, Российской академии медицинских наук и других организаций, которые решают вопросы защиты населения от ЧС и ликвидации их медико-санитарных последствий.

Руководство Службой осуществляет **Министр здравоохранения РФ**, организационно-методическое руководство — Минздрав России (п. 7).

Режимы функционирования (как у всей РСЧС): повседневной деятельности, повышенной готовности, чрезвычайной ситуации (приказ № 1202н, п. 3).

Основные принципы организации ВСМК

учебник, с. 12–13

- **Государственный и приоритетный** характер.
- **Территориально-производственный** принцип — служба строится с учётом экономических и медико-географических особенностей региона.
- **Централизация** и **децентрализация** управления: единая система информации на всех уровнях плюс ведущая роль конкретного уровня в своей ЧС.
- **Плановый** характер — заблаговременная подготовка сил и средств, прогнозирование, планирование взаимодействия.
- **Универсализм** — формирования готовы работать в любой ЧС без существенной реорганизации.
- **Основное функциональное предназначение** — силы службы используют только по их прямому назначению.
- **Этапное лечение с эвакуацией по назначению.**
- **Мобильность, оперативность и постоянная готовность.**
- **Всеобщая подготовка населения** к действиям в ЧС.

Медицина катастроф — наука и практика, **ВСМК** — государственная служба, которая эту практику выполняет. Определение самой медицины катастроф и классификация ЧС — в прошлой памятке «Чрезвычайные ситуации: понятия и классификация».

02 Зачем и когда создана

Зачем. Катастрофы конца 1980-х показали, что обычное здравоохранение с ними не справляется: не было мобильных медицинских формирований, единого управления, резервов, подготовленных кадров. Помощь запаздывала, пострадавших эвакуировали хаотично.

- **Чернобыльская авария** — 26 апреля 1986 г.;
- **взрыв на железной дороге в Арзамасе** — 4 июня 1988 г.;
- **Спитакское землетрясение** в Армении — 7 декабря 1988 г.;
- **железнодорожная катастрофа под Уфой** (взрыв газа при встрече двух поездов) — 4 июня 1989 г.

Отсюда цель службы: **спасти жизнь и сохранить здоровье наибольшего числа людей** при ЧС за счёт быстрого реагирования, готовых мобильных сил и единого управления.

Хронология — даты, которые спрашивают

7 апреля 1990
Постановление Совмина СССР **№ 339** «О создании в стране службы экстренной медицинской помощи в чрезвычайных ситуациях».

14 июня 1990
Постановление Совмина РСФСР **№ 192** — служба экстренной медицинской помощи в ЧС в РСФСР.

25 ноября 1993
Приказ Минздрава РФ **№ 279** (министр Э. А. Нечаев) — создан **Всероссийский центр медицины катастроф «Защита»**.

3 мая 1994 ★
Постановление Правительства РФ **№ 420** «О защите жизни и здоровья населения РФ при возникновении и ликвидации последствий ЧС, вызванных стихийными бедствиями, авариями и катастрофами» — **создана ВСМК**, ВЦМК «Защита» назначен органом её повседневного управления.

28 февраля 1996
ПП РФ **№ 195** «Вопросы Всероссийской службы медицины катастроф» — первое Положение о ВСМК.

26 августа 2013 ★
ПП РФ **№ 734** «Об утверждении Положения о Всероссийской службе медицины катастроф» — **действующее** Положение, № 195 утратило силу.

12 октября 2020
ПП РФ **№ 1671** — функции органа повседневного управления на федеральном уровне переданы **НМХЦ им. Н. И. Пирогова**; с 1 марта 2021 г. их выполняет **Федеральный центр медицины катастроф (ФЦМК)**.

6 ноября 2020
Приказ Минздрава **№ 1202н** — Порядок оказания ВСМК медицинской помощи при ЧС, в том числе медицинской эвакуации (изменения 2021, 2023, 2024).

6 октября 2023
Создан ФЦМК «Южный» в составе НМХЦ им. Н. И. Пирогова.

Если спросят «когда создана» одной фразой: служба экстренной медицинской помощи — в 1990 году (после Чернобыля и Спитака), Всероссийская служба медицины катастроф — ПП № 420 от 3 мая 1994 года.

03 Медико-санитарные последствия ЧС

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

Медико-санитарные последствия ЧС — комплексная характеристика ЧС, определяющая содержание, объём и организацию медико-санитарного обеспечения населения. Проще: всё, что ЧС сделала со здоровьем людей и с возможностями здравоохранения им помочь.

Из чего складываются

1. **Потери населения** — их величина и структура (санитарные и безвозвратные).
2. **Нуждаемость поражённых** в различных видах медицинской помощи, медицинской эвакуации и лечении.
3. **Ухудшение санитарно-гигиенической и санитарно-эпидемиологической обстановки**: разрушение водопровода и канализации, загрязнение воды и продуктов, скопление людей — угроза эпидемий.
4. **Выход из строя сил и средств здравоохранения** в зоне ЧС: разрушение больниц, потери медицинского персонала, медицинского имущества.
5. **Психотравмирующее воздействие** на население и спасателей: острые реакции на стресс, паника, ПТСР.
6. **Ухудшение здоровья населения**, в том числе отдалённые последствия — обострение хронических болезней, последствия облучения, здоровье участников ликвидации.

Потери

ВИД ПОТЕРЬ	КТО В НИХ ВХОДИТ
Общие	безвозвратные + санитарные
Безвозвратные	погибшие в момент ЧС, умершие до поступления на первый этап медицинской эвакуации (в медицинскую организацию), пропавшие без вести
Санитарные	поражённые и заболевшие в результате ЧС, которые нуждаются в медицинской помощи (утратили трудоспособность и поступили на этапы медицинской эвакуации)

Структура санитарных потерь описывается по двум признакам:

- **по тяжести** — крайне тяжёлые, тяжёлые, средней тяжести, лёгкие;
- **по характеру поражения** — механическая травма, ожоги, отравления, радиационные поражения, инфекционные заболевания, комбинированные поражения, психоневрологические расстройства.

Величина и структура потерь зависят от вида и масштаба ЧС, плотности населения, времени суток, своевременности оповещения и защиты, подготовленности людей.

Связь с прошлой темой: катастрофу по масштабу для медицины оценивают именно по санитарным потерям — малая (25–100 пострадавших, из них 10–50 нуждаются в госпитализации), средняя (101–1000 / 51–250), крупная (более 1000 / более 250).

04

Задачи ВСМК по ликвидации медико-санитарных последствий

Отвечать **дословно по Положению** (ПП РФ № 734, п. 3) — своими словами не принимают:

> ЗАДАЧИ СЛУЖБЫ · ПП № 734, П. 3 ★
>
> **а)** быстрое реагирование, мобилизация материально-технических средств и личного состава при ЧС в целях спасения жизни и сохранения здоровья наибольшего числа людей путём оказания им всех видов медицинской помощи своевременно и в полном объёме;
>
> **б)** ликвидация эпидемических очагов;
>
> **в)** создание резерва материальных запасов;
>
> **г)** обучение оказанию медицинской помощи гражданам, в том числе медицинской эвакуации, при ЧС.

Полномочия Службы (п. 4) — это и есть «что она делает при ликвидации»

1. организация ликвидации медико-санитарных последствий ЧС, в том числе организация и оказание медицинской помощи, включая **медицинскую эвакуацию**;
2. сбор, обработка и предоставление информации медико-санитарного характера;
3. **прогнозирование и оценка** медико-санитарных последствий ЧС;
4. информирование населения о медико-санитарной обстановке в зоне ЧС;
5. обеспечение мероприятий по спасению жизни и сохранению здоровья людей;
6. организация дистанционных консилиумов врачей с использованием **телемедицинских технологий**;
7. организация взаимодействия с экстренными оперативными службами;
8. организация связи и информационного взаимодействия органов управления и сил Службы.

На практике ликвидация медико-санитарных последствий включает: **медицинскую разведку**, розыск и вынос поражённых, **медицинскую сортировку**, оказание

медицинской помощи и **медицинскую эвакуацию** (то есть лечебно-эвакуационное обеспечение), санитарно-противоэпидемическое обеспечение, медицинскую защиту населения и спасателей, медицинское снабжение, сохранение и восстановление здоровья участников ликвидации.

05 Лечебно-эвакуационное обеспечение

ОПРЕДЕЛЕНИЕ · УЧЕБНИК, С. 44 ★

Лечебно-эвакуационное обеспечение (ЛЭО) — комплекс организационных, медицинских, технических и других мероприятий по розыску поражённых (больных), их сбору, выносу (вывозу) из очага санитарных потерь, оказанию медицинской помощи на месте поражения (или вблизи от него), отправке на этапы медицинской эвакуации для последующего лечения и реабилитации.

СУЩНОСТЬ СИСТЕМЫ ЛЭО

Последовательное и преемственное оказание медицинской помощи в очаге поражения и на этапах медицинской эвакуации в сочетании с эвакуацией до лечебного учреждения, обеспечивающего **исчерпывающую** медицинскую помощь в соответствии с поражением.

В действующем приказе № 1202н (п. 4) это названо так: ВСМК организует медицинскую помощь (ЛЭО) **на основе системы этапного лечения пострадавших с их эвакуацией по назначению**.

Почему помощь приходится оказывать этапами

условия, определяющие систему ЛЭО, учебник, с. 44

- санитарные потери возникают **одновременно** или за короткое время;
- большинству нужна **первая помощь сразу**, на месте или рядом;
- многим нужна специализированная помощь, но оказать её всем в очаге невозможно;
- **дефицит сил и средств** здравоохранения рядом с зоной ЧС;
- поэтому нужна **эвакуация** в больницы, где помощь будет исчерпывающей, и **подготовка к ней**.

Условия, которые обеспечивают по приказу № 1202н (п. 6)

1. своевременное оказание медицинской помощи в **экстренной форме** в зоне (вблизи зоны) ЧС;
2. медицинская эвакуация в кратчайшие сроки нуждающихся в специализированной помощи в медицинские организации с нужными возможностями;

3. **сокращение количества этапов** медицинской эвакуации.

Требования к системе этапного лечения

- **единое понимание** медицинским персоналом патогенеза поражений и принципов этапного лечения (единая медицинская доктрина);
- достаточное число **профильных коек** на каждом эвакуационном направлении;
- **краткая, чёткая, единая медицинская документация** — первичная медицинская карточка, сортировочные марки.

06 Организационная структура ВСМК

Структуру описывают в три слоя: **кто входит**, **кто руководит** и **как это разложено по уровням**.

Кто входит (функционально)

- служба МК Минздрава (главная; ФЦМК, ТЦМК, ПМГ, бригады, ФМБА)
- служба МК Минобороны
- силы и средства МЧС, МВД, Роспотребнадзора
- органы власти субъектов и местного самоуправления, РАМН, другие организации

Кто руководит

- **Министр здравоохранения РФ** — руководитель Службы
- Минздрав России — организационно-методическое руководство
- на каждом уровне — свои органы управления (вопрос 8)

Нештатные формирования (госпитали, отряды, бригады, группы) создаются на всех уровнях на базе медицинских, судебно-экспертных, образовательных, научных организаций и организаций Роспотребнадзора из их работников. При ЧС поступают в **оперативное подчинение органов управления Службы** соответствующего уровня; за их готовность отвечает руководитель организации (п. 9).

Наращивание сил: если на муниципальном или региональном уровне сил не хватает, привлекают силы федеральных органов, других субъектов и организаций (п. 10). По решению руководителя Службы в ликвидации могут участвовать **все силы, находящиеся в зоне ЧС, независимо от уровня** (п. 11).

07 Уровни организации

ВСМК организована на **пяти уровнях** (ПП № 734, п. 8) ★:

Федеральный
вся страна

Минздрав России; орган повседневного управления — **НМХЦ им. Н. И. Пирогова** (его ФЦМК)

Межрегиональный
федеральный округ

межрегиональные центры МК — ТЦМК 7 городов + НМХЦ им. Пирогова в Москве

Региональный
субъект РФ

орган власти субъекта в сфере здравоохранения; **территориальный центр медицины катастроф**

Муниципальный
муниципальное образование

орган местного самоуправления в сфере здравоохранения; дежурно-диспетчерская служба

Объектовый
организация

подразделение (должностные лица) организации; дежурно-диспетчерская служба организации

Межрегиональные центры медицины катастроф — их функции выполняют ТЦМК в **Екатеринбурге, Нальчике, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Ростове-на-Дону, Санкт-Петербурге и Хабаровске**, а в Москве — НМХЦ им. Н. И. Пирогова.

Для Чувашии: региональный уровень — Минздрав Чувашии и республиканский ТЦМК; межрегиональный (Приволжский федеральный округ) — центр в Нижнем Новгороде.

08 Органы управления ВСМК на каждом уровне

На каждом уровне (кроме межрегионального) есть **три органа управления** и силы: **координационный орган** — комиссия по ЧС и пожарной безопасности, **постоянно действующий** — подразделение, отвечающее за здравоохранение, **повседневного управления** — центр медицины катастроф или дежурно-диспетчерская служба.

УРОВЕНЬ	КООРДИНАЦИОННЫЙ ОРГАН	ПОСТОЯННО ДЕЙСТВУЮЩИЙ ОРГАН УПРАВЛЕНИЯ	ОРГАН ПОВСЕДНЕВНОГО УПРАВЛЕНИЯ
Федеральный	комиссия по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности **Минздрава России**	соответствующее подразделение **Минздрава России**	**ФГБУ «НМХЦ им. Н. И. Пирогова»** Минздрава России (функции выполняет ФЦМК); до 2020 г. — ВЦМК «Защита»
Межрегиональный	—	—	**межрегиональные центры МК** (ТЦМК 7 городов, в Москве — НМХЦ им. Пирогова)
Региональный	комиссия по ЧС и ПБ **органа исполнительной власти субъекта**	**орган исполнительной власти субъекта в сфере охраны здоровья** (минздрав региона)	**территориальный центр медицины катастроф (ТЦМК)**
Муниципальный	комиссия по ЧС и ПБ **органа местного самоуправления**	орган местного самоуправления, управляющий здравоохранением	**дежурно-диспетчерская служба** органа местного самоуправления в сфере здравоохранения
Объектовый	комиссия по ЧС и ПБ **организации**	структурное подразделение (должностные лица) организации по вопросам ЧС	**дежурно-диспетчерская служба организации**

Силы и средства на каждом уровне: федеральный — Минздрава, ФМБА, Минобороны, МЧС, МВД, Роспотребнадзора, РАМН и других организаций; межрегиональный — те же, расположенные в федеральном округе; региональный, муниципальный, объектовый — органов власти своего уровня плюс расположенные на их территории федеральные силы.

Как запомнить: «комиссия — координирует, департамент здравоохранения — постоянно руководит, центр (диспетчерская) — дежурит круглосуточно». Центры медицины катастроф есть только на трёх верхних уровнях, ниже их заменяют дежурно-диспетчерские службы.

09 Функции центров медицины катастроф

Территориальный центр медицины катастроф (ТЦМК)

ТЦМК — **орган повседневного управления ВСМК в пределах субъекта РФ**, работает круглосуточно. Это самостоятельная медицинская организация особого типа или

подразделение медицинской организации (приказ № 1202н, прил. 9).

ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ ТЦМК · ПРИКАЗ № 1202Н, ПРИЛ. 9, П. 6 ★

1. организация и оказание медицинской помощи пострадавшим при ЧС в режиме повседневной деятельности и в режиме ЧС;
2. организация и проведение **медицинской эвакуации** пострадавших;
3. организация **взаимодействия с экстренными оперативными службами** по привлечению сил и средств ВСМК в субъекте во всех режимах;
4. сбор, обработка и предоставление **информации медико-санитарного характера**;
5. **прогнозирование и оценка** медико-санитарных последствий ЧС в субъекте;
6. развитие и совершенствование форм и методов первой помощи, скорой медицинской помощи, внедрение современных методов диагностики и лечения при ЧС;
7. **обучение населения** оказанию первой помощи, медицинской помощи при ЧС;
8. представление отчётности, сбор первичных данных для информационных систем здравоохранения.

Рекомендуемая структура ТЦМК: оперативно-диспетчерский отдел (единая диспетчерская служба скорой помощи и ситуационный центр, круглосуточно); организационно-методический отдел; **бригады экстренного реагирования (БЭР)**, круглосуточно; мобильный медицинский отряд, в том числе с мобильным медицинским комплексом; отделение экстренной консультативной скорой медицинской помощи (**санитарной авиации**); учебно-методический отдел.

Федеральный центр медицины катастроф (ФЦМК)

ФЦМК — структура **НМХЦ им. Н. И. Пирогова**, через которую центр выполняет роль органа повседневного управления ВСМК на федеральном уровне и межрегионального центра для Москвы. С 2023 года есть также ФЦМК «Южный».

- координация взаимодействия органов управления, сил и средств ВСМК;
- организация медицинской помощи и медицинской эвакуации при ЧС федерального масштаба, выдвижение ПМГ по решению Министра здравоохранения;
- разработка научно-методических принципов медицины катастроф;
- подготовка специалистов службы, разработка предложений по обучению населения первой помощи.

В составе ФЦМК — **центр управления в кризисных ситуациях (ЦУКС)**, **центр санитарной авиации и экстренной медицинской помощи** и **три полевых многопрофильных госпиталя**.

Общая формула для ответа: центры медицины катастроф — органы повседневного управления ВСМК. Они круглосуточно отслеживают обстановку, прогнозируют последствия ЧС, планируют и организуют медицинскую помощь и эвакуацию, держат в готовности формирования, взаимодействуют с другими службами и обучают население и медиков.

10 Силы и средства ВСМК для ликвидации последствий

ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Силы — медицинские формирования и медицинские организации (учреждения) с личным составом, предназначенные для ликвидации медико-санитарных последствий ЧС.

Средства — медицинское и санитарно-хозяйственное имущество, специальная техника, транспорт и оснащение, которыми эти силы работают.

ФОРМИРОВАНИЕ И УЧРЕЖДЕНИЕ — В ЧЁМ РАЗНИЦА

Формирование — мобильная структура (госпиталь, отряд, бригада, группа), которую выдвигают в зону ЧС. **Учреждение** — стационарная медицинская организация (больница, центр), которая работает на своём месте и принимает пострадавших.

Кто что даёт

ВЕДОМСТВО	СИЛЫ
Минздрав	**ФЦМК** НМХЦ им. Пирогова (три ПМГ, бригады экстренного реагирования, санитарная авиация); **ТЦМК** (БЭР, мобильные медицинские отряды, санавиация); станции **скорой помощи**; больницы (перепрофилирование и развёртывание коек); нештатные БСМП, врачебно-сестринские бригады, бригады доврачебной помощи; учреждения **ФМБА** (в том числе радиационная медицина)
Роспотребнадзор	центры гигиены и эпидемиологии, противочумные учреждения; нештатные санитарно-эпидемиологические отряды (СЭО) и бригады (СЭБ), специализированные противоэпидемические бригады (СПЭБ), группы эпидемиологической разведки (ГЭР)
Минобороны	военно-медицинские учреждения и формирования: военные госпитали, медицинские отряды специального назначения, бригады специализированной медицинской помощи, санитарно-эпидемиологические учреждения
МЧС	**Центроспас** с аэромобильным госпиталем; Всероссийский центр экстренной и радиационной медицины им. А. М. Никифорова; медицинские подразделения поисково-спасательных формирований; авиация МЧС
МВД	медицинские организации и госпитали МВД, медицинские подразделения

Средства — медико-техническое обеспечение

учебник, приложение 10

- **для первой, доврачебной и первой врачебной помощи:** ППИ, жгут кровоостанавливающий, носимые комплекты санитарного инструктора, фельдшера и врача аварийно-спасательной службы;
- **подвижные комплексы:** автоперевязочная АП-2, подвижный комплекс врачебной помощи (ПКВП), операционно-реанимационный комплекс (КОРП), рентгенодиагностический комплекс (ПРДК), клинико-диагностическая лаборатория (ЛКДП), дезинфекционно-душевая установка ДДА-3;
- **авиация:** медицинский вертолёт Ми-8МБ «Биссектриса», эвакуационно-реанимационный самолёт Ан-26М «Спасатель», реанимационно-операционный самолёт Ил-76МД «Скальпель»;
- **для развёртывания в поле:** палатка УСТ-56, столы перевязочный (СППУ) и операционный (СОПУ) полевые, бестеневой светильник СБПА-15, станок трёхъярусный СП-6, кровати полевые;
- **резерв медицинского имущества** — одна из четырёх задач службы (вопрос 4).

11 Штатные и нештатные формирования

ПРИЗНАК	ШТАТНЫЕ	НЕШТАТНЫЕ
Как создаются	по утверждённому штату в центрах медицины катастроф; работа в формировании — **основная работа** персонала	приказом руководителя **на базе** медицинских, образовательных, научных организаций и организаций Роспотребнадзора **из их работников**
Персонал в обычное время	постоянно в формировании, дежурит	работает на своих рабочих местах; собирается по сигналу
Готовность	**постоянная**, БЭР — круглосуточное дежурство, выезд в минуты	через несколько часов после оповещения; за готовность **отвечает руководитель организации**
Подчинение при ЧС	органу управления ВСМК (своему центру)	поступают в **оперативное подчинение** органа управления ВСМК своего уровня
Оснащение	собственное, по табелю, постоянно при формировании	по табелю, хранится в организации, на базе которой создано

Штатные — что относится

- **полевой многопрофильный госпиталь** ФЦМК
- **бригады экстренного реагирования** (БЭР) ПМГ и ТЦМК
- штатные **бригады специализированной медицинской помощи** ТЦМК
- бригады **санитарной авиации** (экстренной консультативной помощи)
- мобильные медицинские отряды ТЦМК

- выездные бригады **скорой медицинской помощи** (штатные подразделения станций СМП)

Нештатные — что относится

- **врачебно-сестринские бригады** (ВСБ)
- **бригады доврачебной помощи** (БДП)
- нештатные **БСМП** (на базе крупных больниц, клиник вузов, НИИ)
- нештатные госпитали и отряды
- **СЭО, СЭБ, СПЭБ, ГЭР** Роспотребнадзора

Состав и возможности бригад

учебник, с. 16–17; штатные нормативы — приказ № 1202н, прил. 2

БРИГАДА	СОСТАВ	ЧТО ДЕЛАЕТ	ВОЗМОЖНОСТИ
ВСБ	врач-руководитель, старшая м/с, 2 м/с, санитар, водитель-санитар — **6 чел.**	первая врачебная помощь, сортировка, подготовка к эвакуации	**50 поражённых за 6 ч**
Врачебная бригада СМП	врач, 2 фельдшера (или фельдшер и м/с-анестезист), санитар, водитель	сортировка, первая врачебная помощь, эвакуация из очага	50 поражённых за 6 ч
БДП / фельдшерская бригада СМП	фельдшер (м/с) — руководитель, 1–2 м/с, водитель-санитар — **3–4 чел.**	сортировка, доврачебная помощь, подготовка к эвакуации	50 поражённых за 6 ч
БСМП	врачи-специалисты одного профиля и медсёстры (хирургическая, травматологическая, ожоговая, нейрохирургическая, токсикологическая, педиатрическая, психиатрическая и др.)	сортировка нуждающихся в специализированной помощи, специализированная помощь, лечение нетранспортабельных	усиливают больницы, куда поступают пострадавшие

БРИГАДА	СОСТАВ	ЧТО ДЕЛАЕТ	ВОЗМОЖНОСТИ
БЭР ПМГ	врач СМП, хирург, травматолог-ортопед, анестезиолог-реаниматолог, терапевт, м/с-анестезист, операционная м/с, фельдшер СМП, водитель (в каждой смене)	выдвигается первой: оценка последствий, числа и состояния пострадавших, путей эвакуации, района развёртывания ПМГ	круглосуточная готовность

⚠ **Где учебник путается.** На с. 15 он перечисляет ПМГ, БСМП, ВСБ, врачебные бригады СМП и БДП как созданные «по утверждённым штатам», а через абзац называет ВСБ нештатными. Отвечай по Положению: **нештатные — создаются из работников организации на её базе и при ЧС переходят в оперативное подчинение ВСМК**. У врачебной бригады СМП учебник пишет «всего 4 чел.», хотя перечисляет пятерых.

12 Полевой многопрофильный госпиталь ФЦМК

в вопросе он назван «передвижным», официальное название — **полевой многопрофильный госпиталь (ПМГ)**

ЧТО ЭТО

ПМГ — основное мобильное лечебно-диагностическое формирование службы медицины катастроф Минздрава, штатное. Создан в **1994 году** при ВЦМК «Защита», сейчас — структурное подразделение **Федерального центра медицины катастроф НМХЦ им. Н. И. Пирогова**; в ФЦМК **три** таких госпиталя.

до 250
пострадавших в сутки принимает при полном развёртывании

до 150
коек для нетранспортабельных

50 коек
базовая структура по приказу № 1202н

4 вида
транспорта: авто, ж/д, водный, воздушный

Кто направляет: ПМГ федеральных центров медицины катастроф направляется в зону ЧС **по решению Министра здравоохранения РФ** (приказ № 1202н, прил. 1, п. 7).

Первой выдвигается его **бригада экстренного реагирования** — оценить обстановку, число пострадавших, пути эвакуации и место развёртывания.

Задачи и функции

- выдвижение в зону ЧС, **приём и медицинская сортировка** пострадавших;
- оказание медицинской помощи по профилю госпиталя — первичной медико-санитарной, скорой, **специализированной** (учебник: квалифицированной с элементами специализированной);
- **временная госпитализация нетранспортабельных**;
- **подготовка к медицинской эвакуации** в медицинские организации;
- консультативная помощь врачам местных больниц; амбулаторная помощь населению;
- сбор и передача данных о медико-санитарных последствиях, взаимодействие со спасателями.

Структура на 50 коек

приказ № 1202н, прил. 1, п. 12

1. приёмно-сортировочное отделение с санитарным пропускником;
2. диагностическое отделение (лаборатория, кабинет лучевой диагностики);
3. операционно-перевязочное отделение;
4. отделение анестезиологии и реанимации (палата реанимации на 6 коек);
5. госпитальное отделение;
6. бригада экстренного реагирования;
7. отделение дезинфекции;
8. аптека;
9. административно-хозяйственные подразделения, включая пищеблок;
9. помещение для временного хранения трупов.

Профили развёртывания: по приказу — инфекционный, терапевтический, хирургический и иные; на практике госпиталь развёртывали как хирургический, токсикологический, терапевтический, радиологический, педиатрический, туберкулёзный или многопрофильный — в зависимости от ЧС.

Где размещается: в пневмокаркасных модулях, мобильных медицинских комплексах, кузовах-контейнерах, на транспорте, в приспособленных зданиях. Работает автономно в любое время года и суток.

Где работал

- Сирия, Алеппо — помощь получили более 7,5 тыс. человек;
- Турция, землетрясение 2023 года — более 35 тыс. человек за два месяца;
- ЛНР — 1154 пациента, более 3,5 тыс. операций;

- Мариуполь — около 16 тыс. амбулаторных приёмов.

Ответ за 30 секунд: ПМГ — штатное мобильное формирование ФЦМК НМХЦ им. Пирогова (создан в 1994 г. при ВЦМК «Защита»), выдвигается по решению Министра здравоохранения; принимает до 250 пострадавших в сутки, разворачивает до 150 коек; отделения — приёмно-сортировочное, диагностическое, операционно-перевязочное, анестезиологии-реанимации, госпитальное плюс БЭР, дезинфекция, аптека.

13

Центроспас — Государственный центральный аэромобильный спасательный отряд МЧС

ЧТО ЭТО

ФГКУ «Государственный центральный аэромобильный спасательный отряд» МЧС России (Центроспас) — первый в истории России отряд профессиональных спасателей. Проводит аварийно-спасательные и поисково-спасательные работы при ЧС природного и техногенного характера **федерального и международного** уровня.

13.03.1992
создан ПП РФ № 154; к работе приступил 1 июля 1992

Жуковский
Московская область, рядом с аэродромом ЛИИ им. Громова

~500
человек, из них 230 спасателей основного штата

от 5 мин
готовность к выезду; до 16 ч — к вылету на международную ЧС

Структура

12 служб и 5 самостоятельных отделов, в том числе поисково-спасательная, инженерная, авиационно-транспортная, **медицинская**, водолазная, кинологическая. Начинали в 1992 году с 60 человек и пяти служб. В 1996 году в отряд вошёл **экспедиционный аэромобильный госпиталь**, в 1998-м создана водолазная служба, в 2003-м — филиал в Туапсе. Первый начальник — М. И. Фалеев.

Аэромобильный госпиталь отряда

Коек	50

Пропускная способность	100–300 пациентов в сутки
Развёртывание	40 минут после десантирования; полная готовность отделений — 1,5 часа

Авиация: самолёты Ил-76, Ан-74, Ан-148; вертолёты Ми-8, Бо-105, ВК-117.

Международное признание: аттестация ООН по стандартам INSARAG (2011, переаттестации 2016 и 2024 — в **тяжёлом** классе поисково-спасательных команд); классификация ВОЗ как медицинской команды экстренного реагирования (2016).

Как связать с ВСМК: силы МЧС функционально входят в ВСМК (ПП № 734, п. 5). Центроспас извлекает пострадавших и оказывает первую и врачебную помощь в очаге, его аэромобильный госпиталь может работать как этап медицинской эвакуации рядом с очагом, пока не подойдут ПМГ и бригады Минздрава.

14 Этап медицинской эвакуации

ОПРЕДЕЛЕНИЕ · УЧЕБНИК, С. 45 ★

Этап медицинской эвакуации — формирование или учреждение службы медицины катастроф, любое другое медицинское учреждение, развёрнутое на путях эвакуации поражённых (больных) и обеспечивающее их **приём, медицинскую сортировку, оказание медицинской помощи, лечение и подготовку** (при необходимости) к дальнейшей эвакуации.

«Этап оказания медицинской помощи» — то же самое: место, где пострадавший получает определённый вид помощи по пути из очага в больницу.

Задачи этапа

1. приём, регистрация и сортировка поступающих;
2. специальная обработка поражённых, дезактивация, дегазация и дезинфекция их одежды и снаряжения;
3. оказание медицинской помощи (лечение);
4. временное размещение подлежащих дальнейшей эвакуации;
5. изоляция инфекционных больных;
6. изоляция лиц с выраженными психическими нарушениями.

Под эти задачи этап развёртывает **функциональные подразделения**: приёмно-сортировочное, специальной обработки, операционно-перевязочное, госпитальное (для нетранспортабельных), эвакуационное, изоляторы, аптеку, хозяйственные подразделения.

Термины эвакуации

Медицинская эвакуация	вынос (вывоз) поражённых из очага и транспортировка до этапов медицинской эвакуации для своевременной помощи и доставки туда, где помощь будет исчерпывающей. Эвакуация — не самоцель, а вынужденная мера. По закону № 323-ФЗ бывает **санитарная** и **санитарно-авиационная**
Путь эвакуации	маршрут от очага до этапа медицинской эвакуации
Плечо эвакуации	расстояние от пункта отправки до места назначения **и обратно**
Эвакуационное направление	совокупность путей эвакуации, развёрнутых на них этапов и работающего транспорта
Эвакуация по назначению	доставка сразу в то учреждение, где пострадавшему окажут исчерпывающую помощь по его профилю

Сортировочные группы на этапе

учебник, с. 53; сортировка — распределение поражённых на группы по нуждаемости в однородных лечебно-профилактических и эвакуационных мероприятиях

ГРУППА	КТО	ЧТО С НИМИ ДЕЛАЮТ
I	крайне тяжёлые, несовместимые с жизнью поражения, агония	симптоматическая терапия, не эвакуируют; до 20 %
II	тяжёлые с нарастающими расстройствами жизненных функций (шок)	помощь по неотложным показаниям, временно нетранспортабельны; эвакуация в 1-ю очередь, лёжа, с медработником; до 20 %
III	тяжёлые и средней тяжести без угрозы жизни	помощь во 2-ю очередь или отсрочена; эвакуация во 2-ю очередь; до 20 %
IV	средней тяжести с нерезкими расстройствами	на следующий этап без помощи на этом
V	лёгкие поражения	амбулаторное лечение

15 Виды медицинской помощи, оказываемой на этапах

ОПРЕДЕЛЕНИЯ · УЧЕБНИК, С. 45–47

Вид медицинской помощи — комплекс лечебно-профилактических мероприятий, регламентированный нормативными документами, решающий определённые задачи в общей системе помощи и требующий соответствующей подготовки персонала, оснащения и условий.

Объём медицинской помощи — перечень мероприятий в рамках вида помощи; бывает **полный** и **сокращённый** (когда обстановка позволяет выполнить только самое неотложное).

Классическая система — пять видов ★

ВИД	КТО ОКАЗЫВАЕТ И ГДЕ	СРОК	ГЛАВНОЕ В ОБЪЁМЕ
Первая помощь	само- и взаимопомощь, спасатели, полиция, водители — на месте или рядом, табельными и подручными средствами	первые минуты, большинству — **до 30 мин**	прекратить действие поражающего фактора, остановить кровотечение, восстановить проходимость дыхательных путей, СЛР, герметизировать рану груди, иммобилизация, положение
Доврачебная	фельдшер, медсестра — в очаге, БДП, табельными средствами	**1–2 ч**	дополняет первую: воздуховод, ИВЛ мешком «Амбу», инфузия, обезболивание, антидоты, антибиотики, контроль и исправление жгутов, повязок, шин
Первая врачебная	врач — на пункте помощи ВСБ, в поликлинике, здравпункте, ближайшей больнице (1-й этап)	**4–5 ч**	неотложные: трахеостомия, пункция плевры при напряжённом пневмотораксе, остановка кровотечения (зажим, прошивание), противошоковые меры, новокаиновые блокады, отсечение конечности на лоскуте, катетеризация пузыря, антидоты. Может быть отсрочено: исправление повязок, серопрофилактика столбняка, антибиотики
Квалифицированная	хирурги и терапевты широкого профиля — в стационаре (2-й этап)	**8–12 ч**	хирургическая и терапевтическая: неотложные операции, лечение шока, интенсивная терапия
Специализированная	врачи-специалисты — в специализированных больницах и отделениях, со специальным оснащением	как можно раньше	исчерпывающая помощь и лечение до исхода; хирургическая и терапевтическая

Первые три вида оказывают в очаге и на **первом этапе**, квалифицированную и специализированную — на **втором этапе**, в стационаре.

Действующая система — приказ № 1202н и закон № 323-ФЗ

Виды (п. 9)

- **первичная медико-санитарная** — доврачебная, врачебная, специализированная (оказывает ПМГ в зоне ЧС и медорганизации)
- **скорая**, в том числе скорая специализированная (выездные бригады СМП, авиамедицинские бригады)

- **специализированная**, в том числе высокотехнологичная (ПМГ, стационары)

Формы и условия (пп. 10, 12)

- формы: **экстренная** (угроза жизни) и **неотложная** (без явной угрозы)
- условия: вне медицинской организации, амбулаторно, в дневном стационаре, стационарно

Первая помощь по закону — не медицинская помощь (ст. 31 закона № 323-ФЗ): её оказывают до медиков люди, обязанные это делать по закону или специальному правилу. Перечень состояний и мероприятий — приказ Минздрава № 220н от 03.05.2024. Если преподаватель спрашивает по учебнику — называй пять классических видов, а действующую классификацию добавляй как плюс к ответу.

16

Этапы медицинской эвакуации в мирное и военное время

Мирное время — ЧС

Небольшая ЧС (мало пострадавших, больницы города работают, поражающие факторы не действуют): пострадавших везут **сразу в стационары** ближайшего населённого пункта — одноэтапная схема, без потерь времени.

Крупная ЧС — классическая **двухэтапная система** ЛЭО ★:

Очаг поражения

Первая помощь

само- и взаимопомощь, спасатели; **доврачебная** — БДП, фельдшерские бригады

↓

1-й этап · на границе очага

Доврачебная и первая врачебная

ВСБ, бригады СМП, БЭР, сохранившиеся больницы, поликлиники, здравпункты, ПМГ; сортировка и подготовка к эвакуации

↓

2-й этап · вне очага

Квалифицированная и специализированная

многопрофильные и специализированные больницы, усиленные БСМП; лечение до исхода

Сейчас по приказу № 1202н стремятся **сокращать число этапов**: тяжёлых доставляют (в том числе санавиацией) сразу в профильные отделения многопрофильных больниц, минуя промежуточные звенья.

Военное время — многоэтапная (эшелонированная) система

Поле боя

Первая помощь

само- и взаимопомощь, стрелки-санитары, санинструктор роты

↓

МПб

Медпункт батальона

доврачебная (фельдшерская) помощь

↓

МПп / медрота бригады

Медпункт полка (бригады)

первая врачебная помощь

↓

омедб / омедо

Отдельный медбатальон или медотряд

квалифицированная помощь

↓

Госпитальная база

Военные госпитали

специализированная помощь; центральные госпитали и ВМедА — высокотехнологичная, реабилитация

ПРИЗНАК	МИРНОЕ ВРЕМЯ	ВОЕННОЕ ВРЕМЯ
Число этапов	1–2	4–5
Кто работает	ВСМК: гражданское здравоохранение, центры МК, ПМГ, бригады	медицинская служба Вооружённых сил

ПРИЗНАК	МИРНОЕ ВРЕМЯ	ВОЕННОЕ ВРЕМЯ
Эвакуация	по возможности сразу в профильный стационар	последовательно по этапам, «по назначению» на госпитальной базе; авиаэвакуация позволяет пропускать этапы
Условия	поражающие факторы ЧС, но тыл работает	боевая обстановка, угроза повторного поражения, этапы перемещаются за войсками
Общее	одни и те же пять видов помощи, принцип этапного лечения с эвакуацией по назначению, сортировка на каждом этапе, единая документация (первичная медицинская карточка)	

⚠ **Названия военных этапов менялись.** После перехода армии на бригадную структуру первую врачебную помощь оказывает медицинская рота бригады, квалифицированную — отдельные медицинские отряды (омедо). Классическая цепочка «МПб → МПп → омедб → госпитальная база» по-прежнему принимается как ответ.

17

Табельное медицинское оснащение военнослужащих

Табельное — значит положенное по табелю (нормам снабжения) и выдаваемое централизованно. Делится на **индивидуальное** (у каждого военнослужащего) и **оснащение медицинского состава подразделений**.

Индивидуальное — у каждого

СРЕДСТВО	ЧТО ЭТО И ЗАЧЕМ
АППИ-7 (образец 2023)	**аптечка первой помощи индивидуальная**: двухсекционный подсумок, **жгут с турникетом (закруткой)** и рифлёный силиконовый жгут, **гемостатическое средство** на основе хитозана, пакет перевязочный с эластичным бандажом, ИПП-11, таблетки для обеззараживания воды (10 шт.), тактические ножницы, **маркер** (записать время наложения жгута), футляр для шприц-тюбика, памятка
АППИ (2011, «Ратник»)	предыдущая версия, приказ Минобороны № 744 от 21.05.2011: жгут Эсмарха, пакет перевязочный, гемостатическое перевязочное средство, таблетки для обеззараживания воды
ППИ	**пакет перевязочный индивидуальный**: бинт 10 см × 7 м, две ватно-марлевые подушечки 17 × 32 см (одна неподвижна, вторая скользит по бинту), булавка; наружная прорезиненная оболочка стерильна изнутри — ею делают **окклюзионную повязку** при открытом пневмотораксе
ИПП-8, -10, -11	**индивидуальный противохимический пакет** для частичной специальной обработки кожи, одежды и противогаза при попадании ОВ (ФОВ, иприта). ИПП-11 — салфетки с защитно-дегазирующей жидкостью, обладает и дезинфицирующим действием

СРЕДСТВО	ЧТО ЭТО И ЗАЧЕМ
Обеззараживание воды	таблетки (пантоцид, аквасепт) — для воды во флягу
Противогаз и шприц-тюбик	средство индивидуальной защиты органов дыхания; шприц-тюбик с обезболивающим — по решению командования

Аптечка индивидуальная АИ-2 — что было раньше и что ещё спрашивают

ГНЕЗДО	ПРЕПАРАТ	НАЗНАЧЕНИЕ
1	промедол, шприц-тюбик	противоболевое
2	тарен, красный пенал	профилактика отравления ФОВ
3	сульфадиметоксин, большой неокрашенный пенал	противобактериальное № 2 (при расстройстве ЖКТ после облучения)
4	цистамин, два малиновых пенала	радиозащитное № 1
5	хлортетрациклин, неокрашенный пенал	противобактериальное № 1
6	калия йодид, белый пенал	радиозащитное № 2 (блокада щитовидной железы)
7	этаперазин, голубой пенал	противорвотное

Для населения и спасателей сейчас предназначена **АИ-4** (заменила АИ-2 в 2012 году, есть антидот угарного газа) — учебник, с. 23–26.

Групповое и оснащение медицинского состава

- **Аптечка войсковая (АВ)** — в боевых машинах и технике, на 3–4 раненых из экипажа, 800 г: йод 5 %, аммиак 10 %, пантоцид, бинты, повязки медицинские малые, косынка, жгут, булавки.
- **Сумка санитара (СС)** — у санитаров и стрелков-санитаров, первая помощь **30 раненым**.
- **Сумка медицинская войсковая (СМВ)** — у санитарного инструктора, первая и доврачебная помощь **30 раненым**; в развёрнутом виде — рабочее место.
- **Средства выноса и иммобилизации:** носилки санитарные складные, лямка медицинская носилочная, лямка специальная Ш-4, волокуша, щит-носилки, шины лестничные (Крамера), накидка медицинская, шлем-маска для раненых в голову (ШР), нарукавный знак Красного Креста.

Почему аптечку поменяли. Главная предотвратимая причина смерти на поле боя — кровотечение из конечности. Поэтому в новой аптечке два жгута, один с турникетом, гемостатик и маркер для времени наложения, а таблетки от радиации и ФОВ ушли.

Связи с другими предметами

- **Общая хирургия** — временная и окончательная остановка кровотечения (жгут на поле боя, зажим и прошивание сосуда в первой врачебной, перевязка сосуда в квалифицированной); раны и ПХО — основа квалифицированной хирургической помощи; переливание кровезаменителей в противошоковых мерах — трансфузиология.
- **Патофизиология** — травматический и геморрагический шок (почему II сортировочная группа эвакуируется первой и лёжа), синдром длительного сдавления при землетрясениях, острая лучевая болезнь (радиозащитные средства, йодид калия).
- **Топографическая анатомия** — точки пальцевого прижатия артерий и места наложения жгута; трахеостомия и плевральная пункция из объёма первой врачебной помощи.
- **Пропедевтика** — «звук кипящего самовара» (влажные хрипы при отёке лёгких) при отравлении ФОС из ситуационной задачи учебника; перкуссия и аускультация при пневмотораксе.

Самопроверка: ответ одной фразой

1. Что такое ВСМК? −

Функциональная подсистема РСЧС, которая объединяет службы медицины катастроф Минздрава и Минобороны, а также силы МЧС, МВД, Роспотребнадзора и других ведомств; руководит ею Министр здравоохранения (ПП № 734 от 26.08.2013).

2. Зачем и когда создана? −

После Чернобыля, Арзамаса, Спитака и Уфы, чтобы быстро и организованно спасать наибольшее число людей при ЧС; служба экстренной медпомощи — 1990 г. (СМ СССР № 339), ВСМК — ПП РФ № 420 от 3 мая 1994 г.

3. Медико-санитарные последствия ЧС? −

Комплексная характеристика ЧС, определяющая содержание, объём и организацию медико-санитарного обеспечения: потери (санитарные и безвозвратные), нуждаемость в помощи, санитарно-эпидемиологическая обстановка, выход из строя здравоохранения, психотравма, ухудшение здоровья населения.

4. Задачи ВСМК?

Быстрое реагирование и мобилизация сил для оказания всех видов медицинской помощи своевременно и в полном объёме; ликвидация эпидемических очагов; создание резерва материальных запасов; обучение оказанию медицинской помощи, в том числе медицинской эвакуации.

5. Что такое ЛЭО?

Комплекс мероприятий по розыску, сбору, выносу поражённых из очага, оказанию им помощи на месте и отправке на этапы медицинской эвакуации для лечения и реабилитации; в основе — этапное лечение с эвакуацией по назначению.

6. Организационная структура ВСМК?

Руководитель — Министр здравоохранения; функционально объединены службы МК Минздрава и Минобороны и силы других ведомств; представлена на пяти уровнях органами управления и силами, нештатные формирования при ЧС переходят в оперативное подчинение ВСМК.

7. Уровни организации?

Федеральный, межрегиональный, региональный, муниципальный, объектовый.

8. Органы управления по уровням?

Координационный — комиссия по ЧС и ПБ; постоянно действующий — подразделение здравоохранения своего уровня; повседневного управления — НМХЦ им. Пирогова (федеральный), межрегиональные ЦМК, ТЦМК (региональный), дежурно-диспетчерские службы (муниципальный и объектовый).

9. Функции центров медицины катастроф?

Круглосуточное повседневное управление: организация медицинской помощи и эвакуации, взаимодействие с экстренными службами, сбор информации, прогноз последствий ЧС, совершенствование методов помощи, обучение населения первой помощи, отчётность.

10. Силы и средства ВСМК? −

Силы — формирования (ПМГ, отряды, бригады) и медицинские организации всех ведомств с персоналом; средства — медицинское имущество, подвижные комплексы, транспорт и авиация, резервы.

11. Штатные и нештатные формирования — разница? −

Штатные работают в формировании постоянно и готовы сразу (ПМГ, БЭР, штатные БСМП, санавиация); нештатные создаются из работников больниц и других организаций на их базе, собираются по сигналу и при ЧС переходят в оперативное подчинение ВСМК (ВСБ, БДП, нештатные БСМП, СЭО, СЭБ, СПЭБ, ГЭР).

12. ПМГ ФЦМК? −

Штатный полевой многопрофильный госпиталь ФЦМК НМХЦ им. Пирогова (с 1994 г.), выдвигается по решению Министра здравоохранения; до 250 пострадавших в сутки, до 150 коек; приёмно-сортировочное, диагностическое, операционно-перевязочное, реанимационное, госпитальное отделения, БЭР.

13. Центроспас? −

Государственный центральный аэромобильный спасательный отряд МЧС (ПП № 154 от 13.03.1992, г. Жуковский) — первый отряд профессиональных спасателей России, около 500 человек, с аэромобильным госпиталем на 50 коек и аттестацией INSARAG в тяжёлом классе.

14. Этап медицинской эвакуации? −

Формирование или учреждение, развёрнутое на путях эвакуации, которое принимает, сортирует поражённых, оказывает им помощь, лечит и готовит к дальнейшей эвакуации.

15. Виды медицинской помощи на этапах? −

Первая помощь (до 30 мин), доврачебная (1–2 ч), первая врачебная (4–5 ч), квалифицированная (8–12 ч), специализированная; по действующему приказу — первичная медико-санитарная, скорая и специализированная, в экстренной и неотложной форме.

16. Этапы эвакуации в мирное и военное время? −

Мирное: двухэтапная система — очаг и 1-й этап (первая, доврачебная, первая врачебная), 2-й этап — больницы вне очага (квалифицированная и специализированная). Военное: поле боя → МПб → МПп (медрота бригады) → омедб/омедо → госпитальная база.

17. Табельное оснащение военнослужащего? −

Аптечка первой помощи индивидуальная (АППИ-7: жгут-турникет, гемостатик, перевязочный пакет, ИПП-11, таблетки для воды, ножницы, маркер), ППИ, ИПП; у экипажей — аптечка войсковая, у санитара — сумка СС, у санинструктора — СМВ.

Источники

1. Основы медицины катастроф: учебно-методическое пособие / С. Н. Линченко и др. — Краснодар: КубГМУ, 2015 — с. 11–17 (ВСМК), 23–27 (табельные средства), 44–54 (ЛЭО), прил. 2, 10.
2. Постановление Правительства РФ от 26.08.2013 № 734 «Об утверждении Положения о Всероссийской службе медицины катастроф» (ред. от 12.10.2020) — Гарант.
3. Приказ Минздрава России от 06.11.2020 № 1202н «Об утверждении Порядка организации и оказания ВСМК медицинской помощи при ЧС, в том числе медицинской эвакуации» (ред. от 29.10.2024) — Гарант.
4. Федеральный центр медицины катастроф: история, полевой многопрофильный госпиталь.
5. МЧС России: ФГКУ «Центроспас».
6. Состав АППИ-7: учебный портал МЧС; аптечка войсковая — занятие по военно-медицинской подготовке ЗабГУ.

Конспект к занятию по медицине катастроф составил Евгений Якимов, группа М-03-24, медфак ЧГУ, 24.09.2026. Нашли ошибку — напишите в Telegram @Thesameboss.

Нужен такой же конспект или тренажёр к своему зачёту или экзамену? Соберу по вашим материалам — списку вопросов, сборнику тестов, методичке. Пишите в личку в Telegram, условия обсудим.